Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n° PASS

UE 8 : ICM



Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 35 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
Concernant l'histoire du médicament, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. Selon Blaise Pascal, le choix d'affronter la douleur fait la gloire de l'homme car il montre sa maîtrise sur soi-même

B. Théophraste décrit la récolte de l'opium dans Historia Naturae

C. Pline l'Ancien décrit les propriétés antalgiques de l'opium dans Histoire Naturelle au Ier siècle

D. La potion Saint Christopher est une solution buvable de morphine proposée par Twycross et Saunders

E. La révolution de 1873 est marquée par la découverte des récepteurs aux opioïdes

Question 2
Au début du XXe siècle, on pouvait prescrire de la morphine contre :

A. L'anémie

B. L'hypoglycémie

C. Certaines infections sexuellements transmissibles

D. Les névralgies

E. L'hypertension artérielle

Question 3
À propos, de l'usage et des mentalités sur les médicaments, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

A. À Berlin, Eduard Levinstein et Louis Lewin attirent l'attention sur la dépendance physique à la morphine, au début du 19e siècle à travers la "Théorie de l'appétit morbide"

B. 200 000 Américains sont morts par overdose (toutes drogues confondues) en 2021

C. De 1916 à 1976 la consommation médicale de stupéfiants décline

D. En 2018, dans certains états des États-Unis, jusqu'à 57% des décès étaient dû à des overdoses

E. 4,4% des analgésiques obtenus par les patients proviennent d'un proche

Question 4
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. La nifédipine est un médicament anti-angoreux ouvrant les canaux potassiques

B. La cyclo-oxygénase transforme l'acide arachidonique en prostaglandines, lesquels provoquent la réaction inflammatoire

C. La voie d'action du GABA-B passe par l'activation de la PKA

D. La simvastatine doit être activée par la carboxy-estérase en simvastatine acide pour avoir son effet hyperlipémiant

E. L'acébutolol est principalement utilisé pour traiter certaines affections cardiovasculaires, telle que l'hypertension artérielle

Question 5
Concernant les différentes cibles moléculaires, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le nicorandil est un médicament antihypertenseur permettant la fermeture des canaux calciques voltage dépendant

B. Les benzodiazépines agonistes ont une action anxiolytique entre autres et peuvent être activés en présence de GABA

C. Les récepteurs aux glucocorticoïdes sont des récepteurs nucléaires, avec comme ligand potentiel le calcitriol

D. La fluoxétine est un inhibiteur de récepteur

E. Le salbutamol est un exemple d'agoniste du récepteur $\beta 2$ adrénergique

Question 6
Concernant l'étude du principe actif, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Au Moyen Âge, on utilisait de la Spiraea ulmaria pour traiter les douleurs

B. En 1828, Pierre Joseph Leroux affine le procédé de purification de la salicyline

C. En 1763, Edward Stone présente les propriétés antiseptique de l'infusion de feuilles de saule

D. L'aspirine est un des médicaments les plus consommés dans le monde (60 000 tonnes/an)

E. L'aspirine possède les quatre propriétés thérapeutiques suivantes : antipyrétique, analgésique, antiagrégant plaquettaire, antiseptique

Question 7
Concernant le mécanisme d'action de l'acide acétylsalicylique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) ?

A. Son effet principal est l'inhibition de la synthèse de toutes les prostaglandines endogènes

B. La COX 2 constitutive est exprimée au niveau des thrombocytes

C. L'aspirine est un inhibiteur enzymatique irréversible des cyclooxygénases, lesquelles sont responsables de la synthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique

D. La COX 1 constitutive est exprimée dans les reins

E. Le switch catalytique est un effet délétère de l'acide acétylsalicylique

Question 8
Concernant le diabète et ses traitements, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) ?

A. On parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 0,26 g/L

B. Les biguanides font partie des traitements dits d'insulinothérapie

C. Les insulines rapides et très rapides sont de structure identique à l'insuline humaine

D. Dans l'insuline humaine, la chaîne A est à caractère neutre et la chaîne B à caractère acide

E. La proinsuline est obtenue à partir de la préproinsuline en éliminant le « signal peptide » N-terminal

Question 9
Concernant le diabète et ses traitements, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s)

A. L'association de l'insuline la protamine (insuline NPH) vise à augmenter sa solubilité

B. Les insulines rapides ont un délai d'action de 15 min et une durée d'action de 2 - 5 heures

C. Une insuline lente ne présente pas de pic d'action

D. Les biguanides augmentent la sécrétion de l'insuline

E. les polyholosides sont utilisés pour bloquer l'alpha glucosidase

Question 10
Concernant les préparation des formes injectables, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Elles sont lipidiques

B. Elles sont inodores

C. Elles sont isotoniques

D. Elles sont neutres

E. Elles sont stériles

Question 11
Concernant la stérilisation, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les collyres nécessitent une stérilisation

B. L'essai de stérilité décrit par la pharmacopé européenne consiste à la recherche de l'absence de germe vivants

C. La stérilisation par chaleur humide se fait à l'étuve pendant 15 minutes à 121 °C

D. Les produits thermosensibles peuvent être stérilisés par autoclave car la chaleur est plus faible que l'étuve

E. L'insuline injectable peut être stérilisé par filtration stérilisante avec une répartition aseptique

Question 12
Concernant les zones à atmosphère contrôlée (ZAC), laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le traitement de l'air dans une ZAC de classe A peut se faire par traitement UV/ filtration/ surpression

B. Les zones de classe A sont celles où se déroulent les opérations à haut risque comme les opérations de remplissage entre autre

C. Au repos, une ZAC de classe A ne doit contenir aucune particule pour garantir la bonne stérilité de la préparation

D. La classe B n'est pas en contact direct avec la zone A c'est pour cela qu'elle n'a pas besoin de mesure de traitement de l'air

E. Les caractéristiques particulaires à respecter pour chaque ZAC sont définies par la HAS

Question 13
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Pour que la SA diffuse dans un organe, il faut que sa concentration au niveau veineux soit supérieure à celle observée au niveau artériel

B. Seules les formes de SA liées à l'albumine sont actives

C. Les enzymes participant aux réactions de phase I correspondent à des enzymes de fonctionnalisation

D. La SA peut-être excrétée sous forme inchangée

E. Dans le cas d'une pharmacocinétique linéaire, la représentation graphique de la concentration en logarithme par rapport au temps est une droite décroissante

Question 14
Un médicament est injecté par voie IM à une concentration de $5\,mg/L$ pour obtenir une dose finale de $1500\,mg$ dans l'organisme du patient. La constante d'élimination est estimée à $0{,}10\,h^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Au bout de 4 $T_{1/2}$, 87,5% d'un médicament est éliminé

B. Le volume de distribution est d'environ $0{,}33\,L$

C. Le volume de distribution est de $300\,L$

D. La clairance est de $3\,L/h$

E. Le temps de demi-vie d'élimination est de $6{,}9\,h^{-1}$

Question 15
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La posologie est égale à la concentration de SA (mg/L) par unité de temps

B. La courbe de la concentration de médicament en fonction du temps lors d'une administration continue a une allure hyperbolique

C. Lors d'une administration à doses réitérées, pour un intervalle de prise de plus de 6 $t_{1/2}$, il n'y a pas d'accumulation du médicament et une même Cmax à chaque prise

D. Un médicament à marge thérapeutique plus étroite qu'un autre est plus dangereux à la prise

E. La pharmacocinétique ne change pas selon l'âge

Question 16
Concernant la variabilité pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Dans le cas de l'insuffisance rénale, l'augmentation du volume de distribution est liée à l'augmentation de la fraction non-liée

B. Dans le cas de l'insuffisance hépatique, il y a une diminution de la synthèse protéique ou des activités enzymatiques

C. Les paramètres pharmacocinétiques tels que la relation dose-effet au sein d'une population présentent le plus souvent une distribution normale unimodale

D. L'étape pharmacocinétique d'élimination chez la mère est diminuée durant la grossesse

E. La substance active peut être métabolisée au niveau du placenta

Question 17
Concernant les interactions médicamenteuses, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Elles sont définies comme la modification des paramètres pharmacocinétiques d'une substance active uniquement par un autre médicament

B. Il n'existe pas de variation ethnique dans la fréquence des types de métaboliseurs de l'isoniazide

C. Il en existe quatre niveaux, la contre-indication étant la plus grave

D. L'inhibition enzymatique liée à la prise d'antifongiques est immédiate et peut avoir lieu à toutes les étapes pharmacocinétiques

E. Le test de phénotypage donne des résultats stables tout au long de la vie

Question 18
Concernant les études du dossier préclinique du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Les propriétés pharmacocinétiques, étudiées sur des modèles cellulaires et tissulaires, caractérisent l'effet d'une substance dans l'organisme en fonction du temps

B. La toxicité subaigüe d'une substance est évaluée par administration de 3 doses répétées pendant 28 jours

C. La tératogénicité du thalidomide se manifeste par une phocomélie chez les enfants de femmes enceintes traitées

D. Les tests d'aberration chromosomiques in vivo sur des cellules de mammifères sont des tests de mutagénèse

E. On étudie la cancérogénèse d'une molécule par administration continue sur des rongeurs durant toute leur durée de vie

Question 19
Concernant les essais cliniques du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. En phase I, on augmente les doses par paliers chez les mêmes sujets sains

B. La phase II cherche à évaluer les caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques afin de déterminer la dose optimale

C. La phase III a pour objectif de déterminer l'efficacité et la sécurité selon la méthode Gold Standard

D. Les études de non-infériorité ont pour but de rechercher une différence significative en faveur du produit étudié

E. Lors de la mise sur le marché, les risques associés à un médicament sont très bien caractérisés

Question 20
Concernant l'AMM, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Une substance aidant à déterminer un diagnostic médical est considéré comme un médicament

B. Seul la dispensation des médicaments relève du monopole des pharmaciens

C. AMM signifie Autorisation de Marchandisation Mondiale

D. Les médicaments homéopathiques doivent être enregistrés mais ne reçoivent pas d'AMM

E. Le nom et adresse du titulaire de l'AMM doit être inscrit sur le conditionnement secondaire du médicament (notice et/ou boite)

Question 21
Concernant l'AMM, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. L'AMM s'applique pour les préparations magistrales

B. L'obtention de l'AMM d'un médicament orphelin vient obligatoirement d'une procédure de reconnaissance mutuelle

C. L'obtention de l'AMM d'un médicament orphelin vient obligatoirement d'une procédure décentralisée

D. L'AAP (Autorisation d'Accès Précoce) est demandée par l'industriel avant ou après l'AMM

E. Les médicaments orphelins s'adressent aux maladies rares (<1/20000 habitants)

Question 22
Concernant l'AMM, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Pour permettre l'obtention de l'AMM, il faut répondre à deux critères : la qualité et la sécurité

B. Il y a deux types d'AMM : européennes (délivrées par l'EMA) et nationales (délivrées par l'ANSM)

C. Il existe 4 procédures d'enregistrement : une nationale et trois européennes (dont la procédure dite centralisée)

D. L'autorisation d'accès précoce (APP) est un type de procédure spécifique

E. Les médicaments génériques sont conçus à partir de la molécule d'un médicament pas encore autorisé sur le marché (appelé médicament princeps)

Question 23
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Une ASMR V propose un plus grand progrès thérapeutique qu'une ASMR IV, III et I

B. Les médicaments pris en charge à 100% ne sont que les médicaments visant à traiter les maladies de longue durée

C. Parmi les questions pour le SMR, on trouve la question du rapport bénéfice/risque

D. Les différentes natures de traitement sont : curatif, symptomatique et substitutif

E. Parmi les questions pour le SMR, on trouve la question de l'intérêt de santé publique

Question 24
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) participe à la fixation des prix des médicaments non remboursables

B. Le prix des médicaments en France est fixé à partir de critères conventionnels comme le volume de vente prévu ou constaté

C. Le CEPS analyse la qualité méthodologique de l'étude médico-économique présentée par l'industriel

D. Le CEPS ne se prononce pas sur les prix pour l'hôpital

E. La fixation du prix tient compte des alternatives au médicament

Question 25
Concernant les professionnels pouvant prescrire, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les infirmiers peuvent renouveler la prescription de certains contraceptifs oraux

B. Les sages femmes ne peuvent prescrire qu'aux femmes

C. Les kinésithérapeutes peuvent prescrire tous les dispositifs médicaux nécessaires à leurs patients

D. Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire des médicaments appartenant aux listes I et II

E. Le pharmacien peut délivrer une boîte supplémentaire pour un traitement chronique sous certaines conditions

Question 26
Concernant les règles de prescription, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le code de la Sécurité sociale fixe l'aspect technique de l'ordonnance

B. Le nom commercial du médicament doit être écrit sur l'ordonnance

C. Les spécialités vénéneuses sont prescrites uniquement sur ordonnance sécurisée

D. Au delà de trois jour de la date d'établissement d'une ordonnance sécurisée, la délivrance est limitée à la durée restant à courir

E. Les médicaments à prescription hospitalière (PH) ne peuvent pas être prescrits en ville

Question 27
Concernant ce qui doit figurer sur une ordonnance, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le numéro RPPS du patient doit y figurer

B. Le DCI (Directive Commune d'Identification) du médicament prescrit doit y figurer

C. La qualité du prescripteur doit y figurer

D. La signature du prescripteur est facultative

E. La forme galénique du médicament doit y figurer

Question 28
Concernant les effets indésirables, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Ils peuvent survenir en cas d'utilisation normale du médicament

B. Un effet indésirable grave mais toujours en jeu la vie du patient

C. Les médicaments de types macrolides peuvent provoquer des effets indésirables de type B

D. Un médicament présentant des effets indésirables de type B peut provoquer un arrêt de commercialisation

E. Un effet indésirable est considéré comme très rare si sa probabilité de survenu est inférieur à 0,1%

Question 29
Concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Un patient peut faire un signalement d'effets indésirables seulement s'il est capable de prouver que l'effet est provoqué par un médicament précis

B. Les kinésithérapeutes sont obligés de notifier un effet indésirable

C. L'ANSM recueille les déclarations relatives aux effets indésirables et les transmettent aux CRPV

D. La troisième étape de la pharmacovigilance est l'analyse, décision et information

E. Les produits sanguins labiles sont considérés comme des médicaments, c'est pour cela qu'ils suivent le parcours de pharmacovigilance en cas d'effets indésirables

Question 30
Concernant les rôles des acteurs dans le circuit du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le prescripteur doit réévaluer la balance bénéfice/risque après la mise en place d'un traitement

B. Le pharmacien doit uniquement préparer les médicaments prescrits, sans vérifier l'ordonnance

C. L'infirmier doit enregistrer l'administration du médicament et suivre les effets attendus

D. Le patient participe au circuit du médicament en respectant les prescriptions médicales

E. Le médecin est seul responsable du bon usage des médicaments

Question 31
Concernant le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il présente les indications et contre indications

B. Il indique le prix unitaire du médicament

C. Les interactions médicamenteuses n'y figurent pas

D. Les populations à risque y sont indiquées

E. On peut y trouver par exemple le nombre de prises par jour

Question 32
Concernant l'erreur médicamenteuse, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Elle n'est pas d'origine humaine

B. La majorité des erreurs est due à une mauvaise préparation

C. L'erreur d'omission est une cause de l'erreur médicamenteuse

D. L'erreur de conditionnement est une nature de l'erreur médicamenteuse

E. Si elle entraîne un séjour et provoque un préjudice temporaire au patient c' est une erreur avec préjudice

Question 33
Parmi les propositions suivantes concernant les aspects sociétaux du médicament, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La consommation totale de médicaments s'élève à 37 milliards € dont 4 milliards en ville

B. En 2013, la moitié des enfants vivants avec le VIH avaient accès aux ARV

C. La seule différence entre la médecine conventionnelle et les médecines alternatives est le fondement scientifique

D. Le coût de production des antirétroviraux étant élevé, il explique leur faible utilisation dans les pays en voie de développement

E. Les campagnes contre la surutilisation des antibiotiques ont partiellement atteint leur objectif malgré une augmentation de prescription des pénicillines

Question 34
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le marché du médicament est un oligopole

B. Dans le cas d'une élasticité forte, le prix varie plus fortement que la demande

C. L'offre pour un bien est une relation décroissante, plus la quantité offerte est importante moins le prix l'est

D. Le marché du médicament est transparent car très contrôlé et encadré

E. Le marché du médicament est très élastique

Question 35
Concernant la pharmaco-économie, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le RDCR est calculé à partir d'un rapport efficacité/coût

B. L'innovation pharmaceutique, du côté du régulateur, est face à une contradiction : d'un côté il doit réguler les dépenses et de l'autre, valoriser l'innovation

C. Le principe général dans une économie de marché est que les prix doivent refléter les coûts

D. L'externalité désigne les décisions de production ou de consommation d'un individu affectant indirectement la satisfaction ou le profit d'autres agents sans être médiées par le marché

E. Un monopsone désigne un marché où il n'y a qu'un seul acheteur et qu'un seul producteur

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Noha FOUIAL *(LAS2 Biomed, grande star +++)*, Aldo RUCINE *(DFGSM2, RMGT Chimie 24-25, tsé le mec mondial)*, Clémentine GUTTEL *(L1 Chimie, allemande à ses heures perdues)*, Maia VALENTIN *(DFGSM2, grande reine au grand coeur musclé, jtm +++)*, Ayoub EL ABSI *(L.AS2 Biomed, from Rabat to Champigny-sur-Marne, jaloux de ma valise)*, Alycia OUNINI *(DFGSM2, la star des oraux ++)*, Dorian CHAUVET *(L.AS2 Biomed, roi qui fait les meilleurs cookies)*, Minh TRAN *(DFGSP2, pharmagicien ++)*, Aurélien HELBERT *(DFGSP2, pharmacinventeur de questions difficiles)*, Adam EL ABSI *(L.AS2 Biomed, pantalon en velours côtelé + 3arbi ouvert d'esprit)*, Tamina MOUHAMED *(DFGSM2, VP Tuto Pass 24-25, grande reine de mon coeur)*, Morane EBELET *(DFGSM2, MA 24-25, VP Pins 24-25, VP dessins 24-25)*, Etienne ROYER *(DFGSM2, MA 24-25, l'Auvergnat qui vous détruit tous avec son accordéon)*, Pierre-Bartholomé HARLIN *(DFGSM2, aka πR, aka l'informaticien de Bichat)*,

Relecteurs :

Aldo RUCINE *(DFGSM2, RMGT Chimie 24-25, toujours aussi mondial)*, Shirine MOKRANI *(DFGSM2, RMEB Biophy 24-25, aka Shirine mets la cam, aka reine intergalactique)*, Gabriel MARCO *(L.AS2 Biomed, meilleur partenaire pour tricher au loup-garou)*, Kamilia CHEROUALI *(DFGSM2, RM ICM 24-25, Miss Algérie 24-25)*, Adam EL ABSI *(L.AS2 Biomed, toujours une fashion victim, 3arbi ouvert d'esprit)*, Alycia OUNINI *(DFGSM2, toujours cette même reine des oraux)*, Aurélien HELBERT *(DFGSP2, toujours ce même pharmacinventeur de questions difficiles)*, Marwa BELAHSEN *(L.AS3 Chimie, relectrice officielle de l'A2sup)*, Menatallah ABDELGHANY *(DFGSP2, grande pharmareine)*, Liana PARDUTIU *(DFGSM2, RMGT Biophy 24-25, aka Charlotte aux fraises, aka danse rock girl)*, Alicia VERHELLE *(DFGSM2, MA 24-25, co-stagiaire de klité, fan de maxou)*, Morane EBELET *(DFGSM2, MA 24-25, toujours la VP Pins 24-25, VP dessins 24-25)*, Tamina MOUHAMED *(DFGSM2, VP Tuto Pass 24-25, reigne toujours sur mon coeur)*, Maryam HAMOUDA *(L.AS 2 Biomed, grande reine +++)*, Lina RAHMI *(L.AS3, grande queen +++)*

Convertisseurs LaTeX :

Kamilia CHEROUALI (DFGSM2, RM ICM 24-25, toujours Miss Algérie)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO-SANTOS (DFGSM2) aka les grandes reines/stars/queens

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team no pAINS no gain**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Kamilia CHEROUALI (DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP